

일차 의료용 근거기반  
권고 요약 정보

DM

# 당뇨병

## QUICK REFERENCE GUIDE



대한의학회  
Korean Academy of Medical Sciences



질병관리청

알고리즘

선별검사 · 진단기준

당뇨병 관리 · 합병증 관리

[부록]  
진료의뢰·응급 후송 필요

[부록]  
환자 관리 체크리스트



# 일차 의료용 근거기반 당뇨병 권고 요약 정보

권고 요약 정보를 뒷받침하는 근거의 세부사항은  
아래 사이트를 통해  
전체 가이드라인 정보를 확인할 수 있습니다.

## 임상진료지침 정보센터

[www.guideline.or.kr](http://www.guideline.or.kr)

## 일차 의료용 근거기반 디지털가이드라인

[www.digitalcpg.kr](http://www.digitalcpg.kr)



스마트폰 QR코드  
[www.digitalcpg.kr](http://www.digitalcpg.kr)

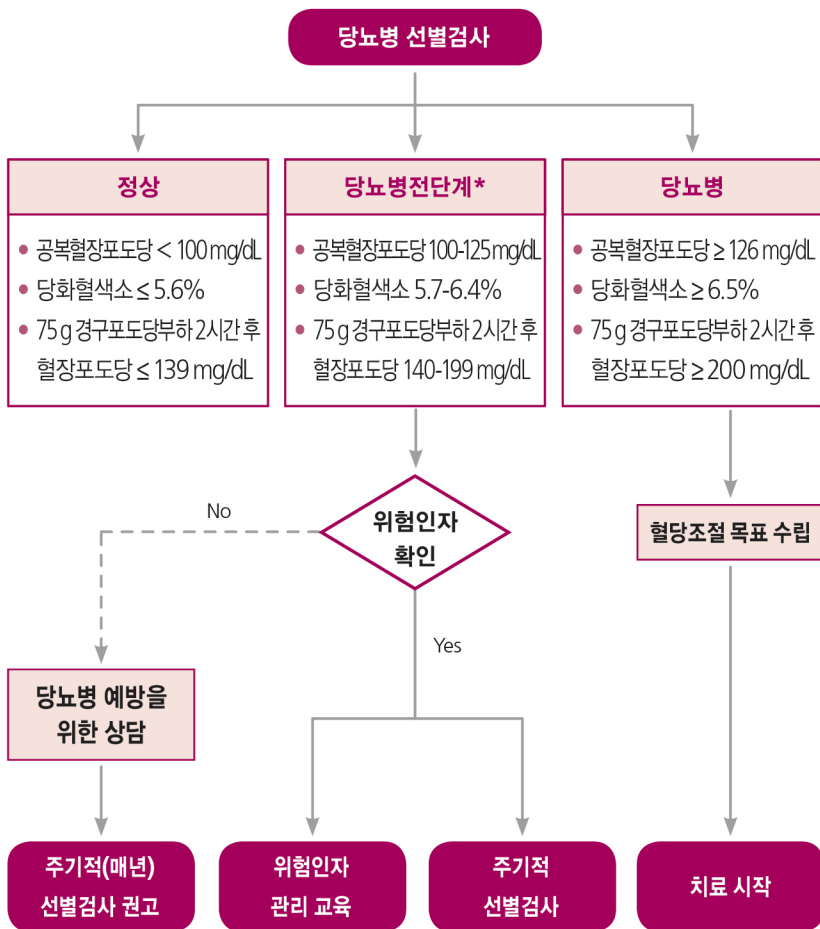


대한의학회  
Korean Academy of Medical Sciences



질병관리청

# 알고리즘 1. 당뇨병 선별검사 및 진단



**\*당뇨병전단계에서의 선별검사**

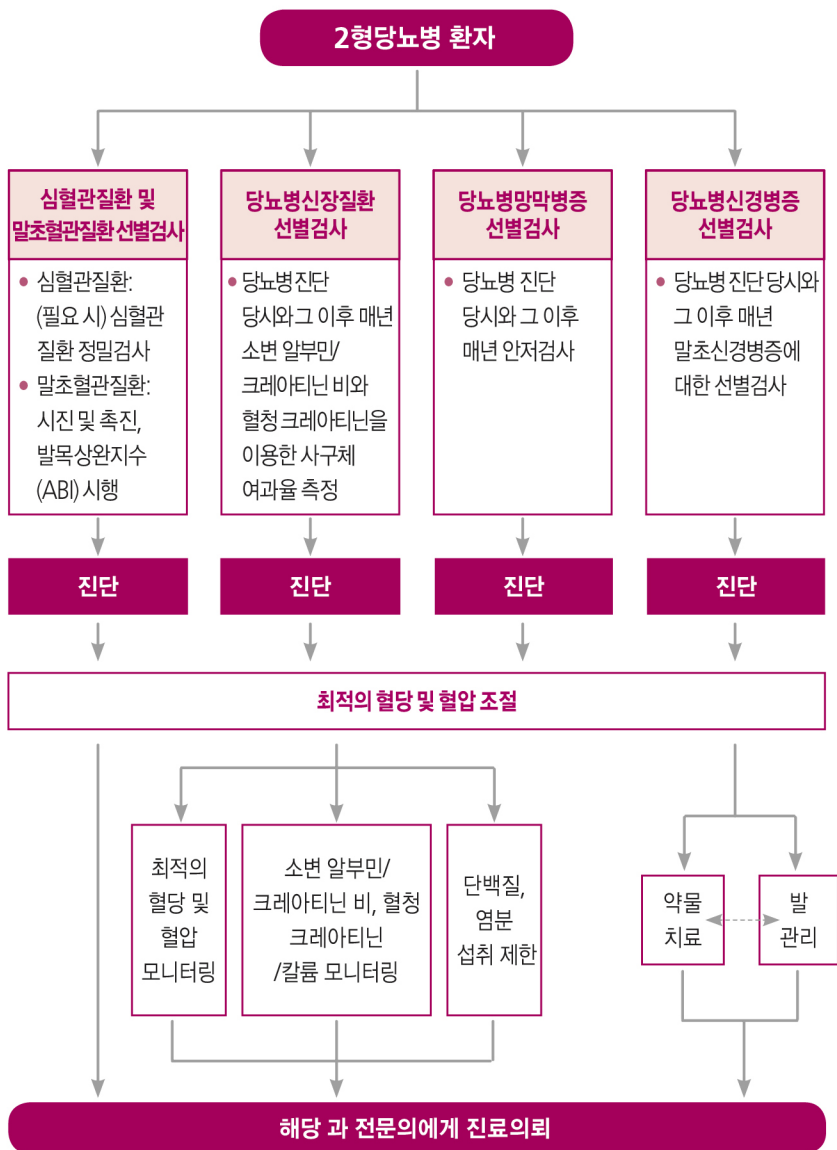
1) 공복혈당포도당 100-109 mg/dL 또는 당화혈색소 5.7-6.0% : 체질량지수가 23 kg/m<sup>2</sup> 이상인 경우 경구포도당부하검사의 시행을 고려한다.

2) 공복혈당포도당 110-125 mg/dL 또는 당화혈색소 6.1-6.4% : 경구포도당부하검사의 시행을 권고한다.

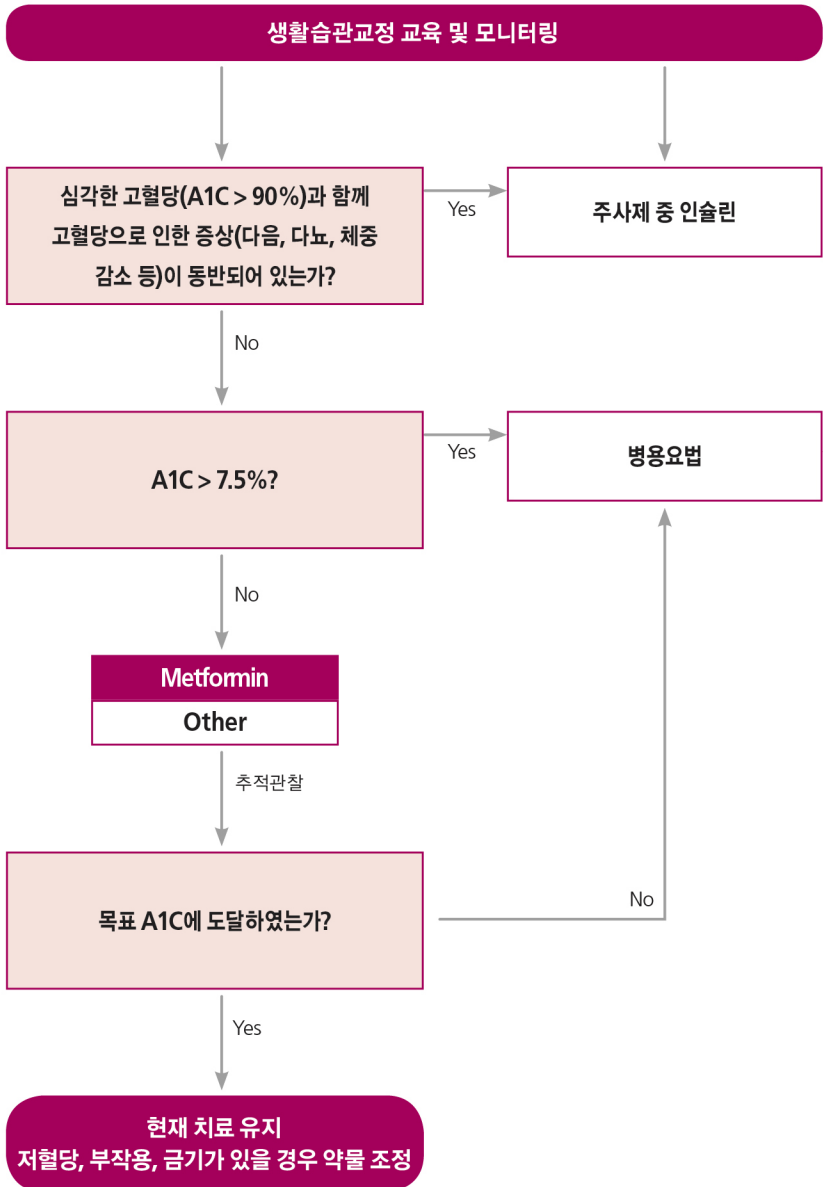
[배경] 경구포도당부하검사는 검사 방법이 번거롭고 시간이 많이 소요되며, 상대적으로 비싸 일차의료기관에서 이를 선별검사로 시행하기 어렵다. 그러나 우리나라의 당뇨병은 서양인에 비해 덜 비만하고 인슐린분비능이 상대적으로 낮아 공복혈당포도당에 비하여 식후혈당이 증가되는 경우가 많고, 특히 노인은 식후고혈당만을 보이는 경우가 흔하다. 따라서 공복혈당포도당이나 당화혈색소만으로 선별검사하면 당뇨병을 진단하지 못하는 경우가 상당히 발생할 수 있다.

이에 공복혈당포도당과 당화혈색소 정도에 따라 2단계로 나누어 필요시 경구포도당부하검사의 시행을 권고한다.

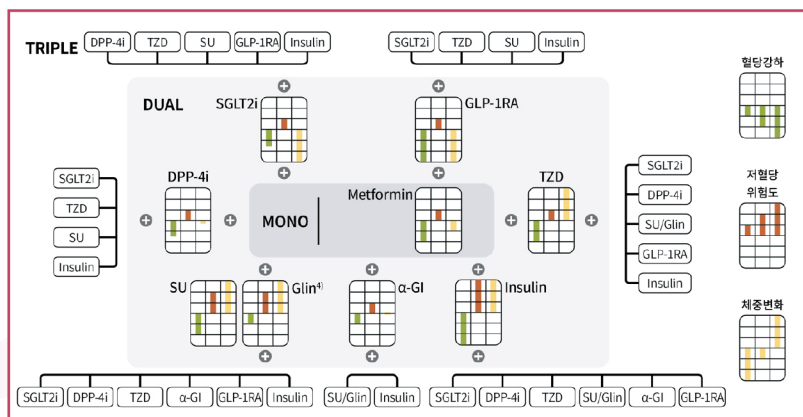
## 알고리즘 2. 만성합병증 관리



## 2형당뇨병 약제치료 알고리즘



## 2형당뇨병 약제치료 알고리즘



목표 A1C에 도달하였는가?

Yes

No

현재 치료 유지  
저혈당, 부작용, 금기가  
있을 경우 약물 조정

기존 약물의 증량 혹은 타계열 약물로  
변경(2제), 타계열 약물 추가(3제 이상)

[출처: 대한당뇨병학회, 2021 당뇨병 진료지침, 2021.]



## 당뇨병 선별검사

### 선별검사

#### 권고

- 당뇨병 선별검사로 공복혈장포도당 측정, 경구포도당부하검사 혹은 당화혈색소 측정을 권고한다.
- 공복혈장포도당 수치가 100-125 mg/dL 또는 당화혈색소 수치가 5.7-6.4 %인 경우 6-12개월마다 공복혈장포도당 또는 당화혈색소 검사를 고려한다.

- 당뇨병의 선별검사는 40세 이상 성인 또는 아래와 같은 위험인자를 가진 30세 이상 성인에게서 매년 시행하는 것이 좋다.
  - 과체중(체질량지수 23 kg/m<sup>2</sup> 이상)
  - 가족(부모, 형제자매) 중 당뇨병 환자가 있는 경우
  - 공복혈당장애나 내당능장애의 과거력
  - 임신당뇨병이나 4 kg 이상의 거대아 출산력
  - 고혈압(140/90 mmHg 이상 또는 항고혈압약제 복용)
  - HDL 콜레스테롤 35 mg/dL 미만 혹은 중성지방 250 mg/dL 이상
  - 다낭난소증후군 또는 흑색가시세포증 등 인슐린저항성이 의심될 때
  - 심혈관질환(뇌졸중, 관상동맥질환 등)

## 당뇨병과 당뇨병전단계 진단기준

### 당뇨병 진단기준 (4가지 기준 중 한 가지 이상 만족 시)

#### 권고

- 당화혈색소  $\geq 6.5\%$
- 8시간 이상 공복 후 혈장포도당  $\geq 126$  mg/dL
- 75 g 경구포도당부하검사 2시간 후 혈장포도당  $\geq 200$  mg/dL
- 당뇨병의 전형적인 증상(다뇨, 다음, 설명되지 않는 체중감소)과 무작위 혈장포도당  $\geq 200$  mg/dL

| 경구포도당부하검사 2시간 후 혈장포도당(mg/dL) |           |          |           |       |
|------------------------------|-----------|----------|-----------|-------|
| 검사 방법(†)                     |           | < 140    | 140 - 199 | ≥ 200 |
| 공복혈장<br>포도당<br>(mg/dL)       | < 100     | 정상       | (내당능장애)   | 당뇨병   |
|                              | 100 - 125 | (공복혈당장애) | 당뇨병전단계    |       |
|                              | ≥ 126     |          |           |       |

(†) 정맥채혈 검사(자기혈당측정으로 진단해서는 안 됨.)

## 당뇨병 관리

### 혈당조절 목표

#### 권고

- 2형당뇨병 성인에게서 일반적인 혈당조절 목표는 당화혈색소 6.5% 미만으로 할 것을 권고한다.
- 혈당조절 목표는 환자의 나이, 신체/정신/사회적 여건, 기대수명, 동반질환 또는 합병증의 중증도, 저혈당 위험, 선호도 등에 따라 개별화할 것을 고려한다.

### 자기혈당측정

#### 권고

- 환자에게 자기혈당측정을 권고하기 전 이에 대해 교육해야 하며, 이후에도 측정의 숙련도, 기기의 정확도, 자기관리에 활용하는 정도 등을 주기적으로 모니터링할 것을 고려한다.
- 인슐린을 사용하는 환자에게는 자기혈당측정을 하도록 권고한다.
- 인슐린을 사용하지 않는 경우에도 자기혈당측정의 권고를 고려한다.
- 자기혈당측정은 매 식사 전후, 취침 전, 운동이나 운전하기 전, 저혈당이 의심될 때 하며, 환자 상태에 따라 검사 횟수나 측정 시기의 조정을 고려한다.

### 연속혈당측정

#### 권고

- 연속혈당측정을 권고할 때 환자에게 전문적이고 체계적인 교육을 먼저 권고한다.
- 다회인슐린주사요법을 하는 2형당뇨병 성인에게서 혈당조절을 위해 연속혈당측정을 고려한다.
- 다회인슐린주사가 아닌 다른 형태의 요법을 하는 2형당뇨병 성인에게서 혈당조절을 위해 연속혈당측정을 고려할 수 있다.

# 당뇨병 관리

## 약물치료

- 당뇨병합병증을 예방하기 위해 혈당을 철저하게 조절해야 하며 이를 위해서는 당뇨병 진단 초기부터 적극적인 생활습관 교정과 함께 개별화된 약물치료를 권고한다.
- 단독요법으로 혈당조절 목표 도달에 실패할 경우 용량을 늘리거나 작용기전이 다른 약제와 병용요법을 고려한다.
- 적절한 생활습관교정과 경구혈당강하제 병용요법에도 불구하고 혈당 조절 목표에 도달하지 못하면 인슐린 사용을 권고한다.
- 심근경색증, 뇌졸중 등 급성질환이 발병했거나, 주요 수술 전후에는 인슐린 사용을 고려한다.
- 임신을 계획 중이거나 임신한 경우 경구혈당강하제를 중단하고 인슐린 사용을 권고한다.

## 권고



# 당뇨병 관리

## 당뇨병 자기관리 교육

- 자기혈당측정 방법, 당화혈색소 알기
- 영양 관리
- 운동 관리 / 체중감량
- 인슐린 조절 및 약물복용관리
- 저혈당 관리
- 교육프로그램 참여
- 특별한 상황에서의 관리

### 저혈당 관리

- 당뇨병 환자에게 저혈당의 원인, 증상 및 징후, 예방법, 대처법을 교육해야 하며 저혈당이 의심될 경우 혈당을 확인하도록 교육할 것을 권고한다.
- 저혈당이 발생하였을 때 환자가 의식이 있으면 15-20 g의 포도당 섭취를 권고한다.
- 저혈당 치료 후 혈당의 회복은 일시적일 수 있으므로, 치료 15분 후 혈당 재검사를 권고한다.
- 저혈당무감지증이 있거나 중증 저혈당이 한 번 이상 반복되는 경우, 저혈당의 재발을 막고 저혈당무감지증을 부분적이거나 회복시키기 위해서 최소 몇 주 동안이라도 환자의 혈당 목표치를 상향조정하는 것을 고려한다.

**권고**

# 당뇨병 관리

## 이상지질혈증 관리

- 혈중 지질검사(총 콜레스테롤, HDL 콜레스테롤, 중성지방, LDL 콜레스테롤)는 당뇨병 진단 당시와 이후 매년 시행하는 것을 고려한다.
- 당뇨병 환자의 혈중 지질이상은 적극적으로 교정하며, 다음과 같은 목표로 조절을 권고한다.

- ① LDL 콜레스테롤 < 100 mg/dL
- ② 중성지방 < 150 mg/dL
- ③ HDL 콜레스테롤 ≥ 40 mg/dL (남자), 50 mg/dL (여자)

### 권고

- 심혈관질환이 있거나 심혈관질환 고위험 당뇨병 환자의 경우 LDL 콜레스테롤을 70 mg/dL 미만으로 조절할 것을 고려한다.
- LDL 콜레스테롤 목표치 도달을 우선시하고, 도달하지 못한 경우 약물 치료를 하며, 일차치료약제로는 스타틴을 권고한다.
- 적정용량의 스타틴으로 LDL 콜레스테롤 목표치에 도달하지 못한 경우 에제티미브 추가를 고려한다.
- 스타틴 투여로 LDL 콜레스테롤은 목표치에 도달하였으나 중성지방이 높거나 HDL 콜레스테롤이 낮은 경우 다른 기전의 지질강하제(파이프레이트, ω-3 지방산)와 병용요법을 고려할 수 있다.

## 당뇨병 관리

### 고혈압 관리

- 당뇨병 환자는 병원 방문 시마다 혈압을 측정하고  
혈압을 140/85 mmHg 미만으로 유지하도록 권고한다.
- 심혈관질환을 동반한 당뇨병 환자는 혈압을  
130/80 mmHg 미만으로 조절할 것을 고려한다.
- 수축기혈압 140 mmHg 이상 또는 확장기혈압 85 mmHg 이상  
지속 시 약물치료 시작을 권고한다.
- 고혈압을 동반한 당뇨병 환자에게 모든 종류의 고혈압약을  
일차약제로 권고한다.
- 알부민뇨 또는 관상동맥질환을 동반한 경우 안지오텐신전환효소  
억제제나 안지오텐신수용체차단제를 권고한다.
- 일차약제로 혈압조절이 되지 않는 경우, 서로 다른 기전을 가진  
약물들의 병용요법을 권고하며 다만 안지오텐신전환효소억제제와  
안지오텐신수용체차단제의 병용은 권고하지 않는다.
- 혈압이 160/100 mmHg를 초과하는 경우 적극적인 생활습관교정과  
함께 처음부터 서로 다른 기전을 가진 두 가지 이상 약물들의 병용요법  
을 권고한다.

### 권고

# 당뇨병 관리

## 비만 관리

### 권고

- 비만한 2형당뇨병 환자는 혈당조절을 위해 생활습관교정으로 체중을 5% 이상 감량하고 유지할 것을 권고한다.
- 비만한 2형당뇨병 환자는 체중감량을 위해 생활습관교정을 하고 실패할 경우 보조요법으로 약물치료를 고려할 수 있다.
- 약물치료를 시작하고 3개월 내 체중이 5% 이상 감소하지 않으면 다른 약제로 변경하거나 약물치료 중단을 고려할 수 있다.
- 체질량지수가  $30 \text{ kg/m}^2$  이상인 2형당뇨병 환자가 비수술치료로 체중감량 및 혈당조절에 실패한 경우 비만수술을 고려할 수 있다.

## 지방간질환

### 권고

- 2형당뇨병 성인에게 지방간질환 평가를 고려한다.
- 지방간질환을 평가하기 위한 일차적인 선별검사로 알라닌아미노기전달 효소(alanine aminotransferase, ALT) 또는 복부 초음파를 고려할 수 있다.
- 지방간질환을 동반한 당뇨병 성인에게 심혈관위험인자 및 지방간질환 치료를 위해 생활습관교정 및 체중감량을 권고한다.
- 지방간 병변 정도를 고려하여 당뇨병 약제 선택을 할 수 있다.

## 합병증 관리

### 권고

#### 심혈관질환 위험인자 확인과 선별검사

- 당뇨병 환자에서 심혈관질환 예방을 위한 적극적인 노력의 일환으로 다음과 같은 심혈관질환 위험인자를 평가를 권고한다.
  - 성별, 나이, 혈압, 흡연여부, 이상지질혈증, 복부비만
- 다음과 같은 상황에서 심혈관질환 정밀검사를 고려한다.
  - 전형적이거나 비전형적인 심장 증상이 있는 경우
  - 심전도에서 허혈이나 경색이 의심되는 경우
  - 말초혈관 혹은 경동맥의 폐색질환이 있는 경우
  - 35세 이상이면서 앉아서 일하는 생활습관을 가진 당뇨병 성인이 강도 높은 운동을 시작하려는 경우
- 무증상의 말초혈관질환이 많으므로 시진 및 촉진을 주의 깊게 시행할 것을 권고한다.

#### 심혈관질환 위험인자 관리

- A** A1C / 적절한 혈당관리 (< 6.5 %)
- B** BP / 적절한 혈압관리 (< 140/85 mmHg)
- C** Cholesterol / 개별화 필요 LDL-C < 100 mg/dL,  
중성지방 < 150 mg/dL  
HDL-C ≥ 40 mg/dL (남자)  
≥ 50 mg/dL (여자)
- D** Diet / 균형식, 적정체중관리
- E** Exercise / 규칙적인 신체 활동
- S** Smoking Cessation / 금연

# 합병증 관리

## ① 당뇨병신장질환

### 권고

- 2형당뇨병 성인에게 당뇨병 진단 시 그리고 적어도 매년 당뇨병신장질환의 선별검사를 권고한다.
- 선별검사로 는 알부민뇨를 확인하기 위한 소변알부민/크레아티닌비와 혈청 크레아티닌을 이용한 추정사구체여과율(eGFR)을 권고한다.
- 3개월 이상 소변알부민/크레아티닌비가 30 mg/g 이상이거나 추정사구체 여과율이 60 mL/min/1.73 m<sup>2</sup> 미만인 경우 당뇨병신장질환 진단한다.
- 당뇨병신장질환 환자는 일차 약제로 안지오텐신전환효소억제제 또는 안지오텐신수용체차단제를 사용하여 혈압을 최적화해야 한다.
- 안지오텐신전환효소억제제 또는 안지오텐신수용체차단제를 사용할 때 혈청 크레아티닌과 칼륨 모니터링을 고려한다.
- 아래의 경우, 신장내과 전문의에게 의뢰를 고려한다.
  - ① 추정사구체여과율이 30 mL/min/1.73 m<sup>2</sup> 미만인 경우
  - ② 소변알부민/크레아티닌비가 300 mg/g 이상이며 추정사구체여과율이 60 mL/min/1.73 m<sup>2</sup> 미만인 경우
  - ③ 혈압이 조절되지 않는 경우
  - ④ 고칼륨혈증이 치료되지 않는 경우

## ② 당뇨병망막병증

### 권고

- 당뇨병망막병증의 진단 및 진행을 알아보기 위해 선별검사로써 안저검사 및 포괄적인 안과검진을 해야 한다.

## ③ 당뇨병신경병증

### 권고

- 당뇨병말초신경병증에 대한 선별검사는 당뇨병 진단 당시에 시행하고 그 이후 매년 선별검사를 시행한다.

## 특수상황/암 선별검사

### 권고

- 당뇨병 환자에게 암 발생을 낮추기 위해 적절한 신체활동량을 유지해 비만을 예방하고, 과다한 음주는 피하며, 금연하도록 권고한다.
- 당뇨병 환자들에게 동일 연령대에서 권고되는 암 선별검사를 권고한다.

## 진료의뢰 혹은 응급의료센터로 후송이 필요한 경우

| 대분류         | 소분류                | 진료의뢰 혹은 응급의료센터로<br>후송이 필요한 경우                                                                                      |
|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 당뇨병<br>관리   | 약물요법               | <ul style="list-style-type: none"> <li>혈당강하제의 부작용 발생, 혈당조절 불량, 집중인슐린요법 필요, 당뇨병의 급성 및 만성 합병증으로 약제 조정이 필요</li> </ul> |
|             | 저혈당                | <ul style="list-style-type: none"> <li>반복되는 저혈당, 응급처치에도 지속되는 저혈당, 저혈당 혼수</li> </ul>                                |
| 당뇨병과<br>합병증 | 심혈관/<br>말초혈관<br>질환 | <ul style="list-style-type: none"> <li>심혈관질환 선별검사에서 양성소견</li> </ul>                                                |
|             | 망막병증               | <ul style="list-style-type: none"> <li>당뇨병망막병증의 의심되는 환자는 안과전문의에게 의뢰</li> </ul>                                     |
|             | 발질환                | <ul style="list-style-type: none"> <li>당뇨병발질환, 궤양 및 말초혈관질환이 발생하면 상급병원으로 의뢰</li> </ul>                              |
|             | 급성<br>합병증          | <ul style="list-style-type: none"> <li>급성합병증이 진단되면 가까운 상급병원 응급실로 바로 전원</li> </ul>                                  |

## 진료의뢰 혹은 응급의료센터로 후송이 필요한 경우

| 대분류          | 소분류               | 진료의뢰 혹은 응급의료센터로<br>후송이 필요한 경우                                                                                    |
|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 당뇨병과<br>특수상황 | 암 선별검사            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 암 진단 시 치료 가능한 상급병원으로 의뢰</li> </ul>                                      |
|              | 소아<br>청소년기<br>당뇨병 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 소아청소년 당뇨병 환자는 소아청소년 당뇨병 전문의에게 의뢰</li> </ul>                             |
|              | 당뇨병과 임신           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 임신당뇨병 환자 혹은 당뇨병 환자가 임신한 경우, 혈당조절이 적절히 되지 않을 시에는 당뇨병 전문의에게 의뢰</li> </ul> |
|              | 수술                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 수술을 앞둔 당뇨병 환자는 당뇨병 전문의에게 의뢰</li> </ul>                                  |

# 당뇨병 환자 관리 체크리스트

## 첫 방문 시

| 항목        |                 | 기준/목표/권고사항                                                                                                                    |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문진 및 기초검사 | 위험인자 확인         | <ul style="list-style-type: none"> <li>가족력, 공복혈당장애나 내당능장애의 과거력, 당뇨병 유병기간, 흡연여부 확인</li> </ul>                                  |
|           | BMI/허리둘레        | <ul style="list-style-type: none"> <li>과체중 : BMI 23 kg/m<sup>2</sup> 이상</li> <li>복부비만 : 허리둘레 남자 90 cm, 여자 85 cm 이상</li> </ul> |
|           | 혈액검사            | <ul style="list-style-type: none"> <li>당뇨병 진단기준 : 공복혈장포도당 126 mg/dL 이상, 당화혈색소 6.5% 이상</li> </ul>                              |
|           | 혈압              | <ul style="list-style-type: none"> <li>고혈압 진단기준 : 진료실혈압 140/90 mmHg 이상</li> </ul>                                             |
| 자기관리 권고   | 생활습관 파악 및 개선 권고 | <ul style="list-style-type: none"> <li>금연, 금주, 운동, 균형 잡힌 식사 권고</li> </ul>                                                     |
|           | 자기관리 교육 실시      | <ul style="list-style-type: none"> <li>당뇨병 환자의 일일체크사항, 저혈당 관리, 자기혈당측정, 응급진료 필요 상황 확인, 당뇨병 수첩 기록방법(자기혈당측정치, 식사기록 등)</li> </ul> |
|           | 의료기관 교육 프로그램    | <ul style="list-style-type: none"> <li>참여 권고</li> </ul>                                                                       |

# 당뇨병 환자 관리 체크리스트

## 첫 방문 시

| 항목                    |             | 기준/목표/권고사항                                |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------------|
| 지질검사                  | HDL-C       | • 목표 : 남자 40 mg/dL, 여자 50 mg/dL 이상        |
|                       | 중성지방 (TG)   | • 목표 : 150 mg/dL 미만                       |
|                       | LDL-C       | • 목표 : 100 mg/dL 미만                       |
| 합병증<br>예방 검사<br>확인/권고 | 당뇨병<br>신장질환 | • 소변 알부민/크레아티닌 비,<br>혈청 크레아티닌을 이용한 사구체여과율 |
|                       | 당뇨병<br>망막병증 | • 안저검사                                    |
|                       | 당뇨병<br>신경병증 | • 신경학적 검사                                 |
|                       | 당뇨병<br>발질환  | • 발 건강상태 확인(궤양)                           |

# 당뇨병 환자 관리 체크리스트

## 매 방문 시

| 항목            |                  | 기준/목표/권고사항                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문진 및<br>기초검사  | BMI/<br>허리둘레     | <ul style="list-style-type: none"> <li>목표 : 초기 체중의 5-10% 감량<br/>(BMI 25 kg/m<sup>2</sup> 이상일 때)<br/>허리둘레 남자 90 cm /<br/>여자 85 cm 미만 유지</li> </ul>               |
|               | 혈당포도당            | <ul style="list-style-type: none"> <li>목표 : 공복혈당포도당 80-130 mg/dL,<br/>식후 2시간 혈당포도당 180 mg/dL 미만</li> </ul>                                                      |
|               | 혈압               | <ul style="list-style-type: none"> <li>목표 : 140/85 mmHg 미만</li> <li>고혈압 (진료실혈압 140/90 mmHg 이상)<br/>이거나 3개월간 치료적 생활습관 교정으로<br/>목표에 도달하지 못한 경우 약물치료 권고</li> </ul> |
| 자기관리<br>확인/권고 | 생활습관 개선<br>관찰/확인 | <ul style="list-style-type: none"> <li>금연, 금주, 운동, 균형 잡힌 식사</li> </ul>                                                                                          |
|               | 자기관리<br>실천 관찰/확인 | <ul style="list-style-type: none"> <li>당뇨병 수첩 기록 확인(자기혈당측정치, 식사기록 등)</li> </ul>                                                                                 |
|               | 의료기관 교육<br>프로그램  | <ul style="list-style-type: none"> <li>참여 확인</li> </ul>                                                                                                         |

## 3개월

| 항목             |       | 기준/목표/권고사항                                                                                                |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 혈당검사<br>(혈액검사) | 당화혈색소 | <ul style="list-style-type: none"> <li>목표: 6.5% 이내</li> </ul>                                             |
|                | 혈당포도당 | <ul style="list-style-type: none"> <li>목표: 공복혈당포도당 80-130 mg/dL,<br/>식후 2시간 혈당포도당 180 mg/dL 미만</li> </ul> |

# 당뇨병 환자 관리 체크리스트

## 매년

| 항목              |           | 기준/목표/권고사항                             |
|-----------------|-----------|----------------------------------------|
| 지질검사            | HDL-C     | • 목표 : 남자 40 mg/dL, 여자 50 mg/dL 이상     |
|                 | 중성지방 (TG) | • 목표 : 150 mg/dL 미만                    |
|                 | LDL-C     | • 목표 : 100 mg/dL 미만                    |
| 합병증 예방 검사 확인/권고 | 당뇨병 신장질환  | • 소변 알부민/크레아티닌 비, 혈청 크레아티닌을 이용한 사구체여과율 |
|                 | 당뇨병 망막병증  | • 안저검사                                 |
|                 | 당뇨병 신경병증  | • 신경학적 검사                              |
|                 | 당뇨병 발질환   | • 발 건강상태 확인(계양)                        |

## 필요 시

| 항목           | 기준/목표/권고사항                          |
|--------------|-------------------------------------|
| 백신접종 확인/권고   | • 인플루엔자(계절독감), 폐렴사슬알균, B형간염, 코로나-19 |
| 암 선별검사 확인/권고 | • 동일 연령대에서 권고되는 암 선별검사 시행을 권고       |









# 당 노 병

## QUICK REFERENCE GUIDE

일차 의료용 당뇨병 가이드라인 개발 참여 학회

대한당뇨병학회, 대한개원의협의회, 대한내과학회, 대한비만학회,  
대한신장학회, 대한소아과학회